

1 - 01- Plaie Faciale - Pr. MANSOURI

Bonjour tout le monde, nous allons entamer cette série de cours de chirurgie maxillofaciale intégrée dans le module maxillo-oral-ophtalmologie, cette série de cours qui va concerner les différents chapitres des traumatismes maxillofaciaux, des cancers orofaciaux, l'articulation temporomandibulaire et les tumeurs osseuses maxillofaciales ainsi que les malformations. Concernant le chapitre traumatisme maxillofaciaux, nous allons les entamer par l'étude de la plaie faciale conduite pratique, donc sujet de ce cours. Ce cours, comme objectif éducationnel et à son issue, vous devez être capable d'indiquer les étapes de l'examen clinique d'une plaie faciale aux urgences, de différencier par l'examen clinique une plaie simple d'une plaie complexe, de citer les particularités topographiques des différentes plaies faciales, de citer également les quatre risques lésionnels d'une plaie jugale et de proposer les trois gestes utiles en cas de morsure.

Au niveau du plan, après introduction, nous allons classer les plaies, établir la conduite de l'examen clinique, la conduite thérapeutique pratique avant de conclure. En guise d'introduction, la plaie classiquement est une solution de continuité des parties molles cutanées ou muqueuses au niveau de la face, très fréquente d'une manière générale et particulièrement dans notre contexte par les accidents de la voie publique, les âmes blanches, elle affecte le sujet jeune et qui pose deux problèmes. D'abord le problème de sa banalité apparente alors qu'elle peut être cachée où les lésions sont jacentes et être grave, mais également ses séquelles qui peuvent être fonctionnelles ou morphologiques très handicapantes.

La plaie peut être améliorée au niveau de son pronostic par une réparation primaire adéquate mais également en adoptant une attitude de pratique stéréotypée. Classification des plaies Nous en disposons de deux. D'abord une classification selon le type de plaie et qui va distinguer de la plaie franche à la plaie plus importante avec perte de substance.

Donc premièrement la plaie franche simple et superficielle comme on voit sur cette photo de cette plaie frontopalpebrale passant par le sourcil. Ensuite les plaies transfixiantes donc qui vont traverser une région telle cette plaie jugale qui traverse la joue ou bien traverser une structure telle la lèvre, le nez, la paupière ou l'oreille. Il y en a trois les plaies contuses donc avec des berges non linéaires et irrégulières et en quatre les plaies avec lésions sous-jacentes soit une lésion noble soit une fracture sous-jacente, le cas de cette plaie frontale avec fracture de l'étage antérieur et enfin des plaies avec perte de substance telle que cette perte de substance labiale supérieure.

Donc quand on classe une plaie par le simple examen clinique en fonction de son type, si ça permet de classer anatomiquement la plaie selon l'importance des dégâts anatomiques à son niveau. Classification selon la complexité La complexité s'oppose à la simplicité et oppose une plaie simple d'une plaie complexe. Par définition une plaie simple c'est une plaie sans lésion noble et sans perte de substance Lésion noble au niveau facial c'est le cerveau, c'est le globe

oculaire, le nerf facial.

Le cas donc de cette plaie simple, linéaire et superficielle sans lésion noble et sans perte de substance. On oppose la plaie simple à la plaie complexe. Une plaie complexe peut être définie comme une plaie soit avec perte de substance, soit relevant d'une étiologie télémorsure, les plaies par arme à feu ou les plaies par pare-brise.

Aussi une plaie de lésion noble avec lésion noble relevant de certaines topographies et de lésions associées. La complexité peut associer plus ou moins toutes ces caractéristiques. Le cas par exemple de ce patient porteur d'une plaie avec perte de substance du sourcil et une plaie palpébrale à topographie particulière mais aussi des dermabrasures.

Conduite de l'examen aux urgences. Avant de réparer une plaie, il va falloir d'abord examiner le patient et faire un examen général sommaire pour éliminer une urgence vitale qu'il va falloir assister, donc qu'elle soit respiratoire ou hémodynamique ou neurologique. Une lésion associée de traitement prioritaire, par exemple un écrasement de membre, une fracture du rachis.

Une plaie très hémorragique faciale ou autre qui va nécessiter d'abord d'assurer l'hémostase ou bien de comprimer la plaie qui s'allie avant de penser à faire des sutures, à le réparer. Après cet examen sommaire, on établit un examen maxillofacial. Cet examen maxillofacial au niveau de la plaie doit répondre à cinq questions et donc à cinq objectifs.

D'abord 1. Quel est l'agent causal? L'agent causal est-ce une plaie par arme blanche? Est-ce une morsure? Est-ce un pare-brise? etc. Est-ce que la plaie est isolée ou associée à une lésion sous-jacente faciale ou intégrée dans le cadre d'un polytraumatisme? 2. Quel type de plaie? On vient de le voir, donc est-ce qu'elle est simple ou complexe? Est-ce qu'elle est superficielle ou avec perte de substance? 3. Quelle est sa topographie? Et nous on est très attentifs aux topographies frontales qui abritent le cerveau. La topographie orbitaire, la topographie jugale et bien d'autres.

Et puis enfin les lésions sous-jacentes. Or l'interrogatoire en premier de l'examen clinique va répondre tout simplement à la première question agent causal. L'examen maxillofacial par l'inspection et la palpation des téguments et des reliefs osseux va pouvoir répondre et classer la plaie au niveau de son type, sa topographie et préciser son caractère isolé ou associé.

L'examen des cavités nasales, buccales, orbitaires et conduits auditifs va chercher une lésion sous-jacente. Et l'examen neurologique facial moteur sensitif et sensoriel par la recherche de la mimique faciale et son évaluation de la sensibilité des trois étages de la face et l'examen des organes de sens qui va permettre d'évaluer la gravité de la plaie et donc son caractère simple ou complexe et aussi son type. La palpation des reliefs osseux donc par l'examen clinique classique maxillofacial au niveau du rebord orbitaire supérieur et inférieur, le nez, la région maxillaire, l'articulation temporomandibulaire pour rechercher donc une fracture maxillofaciale sous-jacente.

L'examen topographique, donc une fois qu'on a situé la plaie dans l'une des régions de la face,

on va se concentrer sur cette région, par exemple au niveau de la région frontale. Il faut automatiquement chercher par l'examen clinique plus précis une déformation frontale faisant suspecter une fracture du sinus frontal ou une fracture plus complexe sous-jacente de l'étage antérieur qui va faire suspecter une lésion neurologique et cérébrale. Hypoesthésie susorbitaire, la rhinorrhée et l'anosmie.

Les plaies crâneuses cérébrales sont très fréquentes chez l'enfant et doivent rechercher les signes de gravité d'une atteinte neurosurgicale. La région orbitopéplébrale, donc les plaies à son niveau sont réputées rétractiles faisant confusion avec les pertes de substances. Une plaie à ce niveau-là et au niveau de cette région orbitopéplébrale doit faire démarrer un examen stéréotypé.

D'abord de la paupière supérieure à la recherche d'amptosis par atteinte du releveur. D'un larmoiement au niveau du contus intérieur interne par atteinte des voies lacrymales. Un examen ophtalmologique du globe de l'acuité visuelle qui risque de chuter.

Du réflexe photomoteur à la recherche d'humidité et d'amnios. De l'oculomotricité à la recherche d'une diplopie. Cela par compression du nerf optique mais aussi fracture du plancher de l'orbite qui peut être associé à une plaie palpébrale et aussi donc se manifestant par la diplopie, par l'hémorragie sous-conjonctivale.

Toutes ces lésions et ce processus lésionnel qui doit être recherché systématiquement par l'examen clinique est un processus qui va représenter donc, doit rechercher une urgence maxillofaciale et ophtalmologique qui vont nécessiter en urgence d'agir pour traiter ces lésions. La région jugale en le fait, elle abrite le nerf facial, le conduit parotidien, la glande parotide et le nerf intra-orbitaire. Et donc l'examen clinique doit chercher une paralysie faciale, l'exploration par le biais du conduit parotidien donc à la recherche d'une plaie à son niveau, une lésion de la parotide, une hypoesthésie sous-orbitaire et une plaie transfixiante qui est septique et là on voit sur la photo cette plaie avec atteinte du nerf facial et cette deuxième plaie avec atteinte du canal du sténon ou du conduit parotidien, donc là l'autre plaie, pareil sur les photos, donc vous voyez bien la plaie qui a été suturée sans explorer le nerf.

La région labiomentonnière, donc cette région qui est en relation avec la mandibule et les dents et avec le maxillaire au niveau de la lèvre supérieure et aussi les dents, les plaies sont réputées rétractiles avec pseudo perte de substance, les plaies sont transfixiantes à son niveau, elles sont septiques et ces plaies donc vont nécessiter une antibiothérapie par conséquent. L'hypoesthésie labiomentonnière doit être recherchée, les fractures aussi alveolodentaires peuvent s'associer à ces plaies et doivent être redoutées à l'examen clinique. La région nasale, donc à ce niveau là, les plaies peuvent être transfixiantes et très hémorragiques mais elles peuvent aussi être associées à des fractures du nez qu'il va falloir rechercher par l'examen clinique mais aussi par des explorations paracliniques.

Alors on voit que l'examen clinique seul est très important et fondamental parce qu'il permet à lui

seul de classer la lésion, de dicter une attitude pratique et nous permettre donc de mener une conduite thérapeutique adéquate. Quelle conduite pratique adopter devant une plaie de la face après un examen clinique ? Eh bien, en fonction de l'importance de la plaie, alors les plaies simples après détecter et diagnostiquer à l'examen clinique vont être réparées par un médecin urgentiste et traitées en ambulatoire. Sauf chez l'enfant, on est obligé de les réparer parfois sous anesthésie générale mais bien souvent et d'une manière générale ces plaies sont réparées sous anesthésie locale.

Et on voit cette plaie sur la photo de gauche donc réparée par simple surjet intradermique sous anesthésie locale. Or la conduite pratique des plaies simples sera très différente par rapport aux plaies complexes. Les plaies complexes qu'on connaît maintenant par l'examen clinique et en connaissant bien évidemment notre classification.

Or elles sont complexes parce qu'elles sont associées à une lésion noble ou bien par l'orthopographe ou bien par une lésion sous chassante pour certaines étiologies. Et donc ces lésions vont être nettoyées, protégées et ensuite explorées par des examens par clinique ou bien explorées sous anesthésie locale par un spécialiste. Donc ce ne sera pas des plaies réparées aux urgences par un urgentiste mais ce sera un chirurgien maxillofacial qui va les réparer souvent en milieu hospitalier et bien souvent sous anesthésie générale.

Et là on regarde cet exemple de plaie jugale transfixante qui a imposé la réparation de la muqueuse en endobécal, la réparation du conduit parotidien et des plans profonds et superficiels. Ce n'est une plaie complexe par sa situation, par les organes nobles qu'elle a lésés et son caractère transfixionnel. Les formes simples, conduites pratiques quelques conseils concernant les plaies du scalp, le rasage est conseillé des berges parce que les cheveux se confondent avec les fils et c'est difficile mais aussi au niveau de la scepticité de la plaie.

Il faut laver, nettoyer et raser et puis fermer bien évidemment. Au contraire, concernant le sourcil, il faut proscrire le rasage parce que les poils du sourcil sont un élément de repérage et d'alignement et donc c'est le premier point qu'on met sur la plaie, c'est celui de l'alignement du sourcil, ce qui va prévenir le décalage. Au niveau de la lèvre aussi, supérieure ou inférieure, la lignée cutanée muqueuse est un repère de suture et d'alignement.

Le fait de mettre un point en premier sur la lignée cutanée muqueuse va assurer le bon repérage et le bon alignement et prévenir le décalage. Quant à la muqueuse, même si les plaies sont simples, elle reste sceptique et elle impose de compléter l'ordonnance par une antibiotérapie et des soins de bouche. Or, les plaies complexes, conduites pratiques, en cas de lésion osseuse suspecte en sous-jacent, il faut la protéger la plaie et prescrire une tomodensitométrie pour explorer la fracture sous-jacente avant de fermer la plaie.

Pareil pour les plaies crânio-cérébrales, ce sont des urgences neurochirurgicales, protéger la plaie et pratiquer une tomodensitométrie pour évaluer l'importance des lésions sous-jacentes

crânio-cérébrales. Toujours dans les plaies complexes, les lésions nobles pour le globe oculaire, c'est une urgence ophtalmologique et maxillofaciale, donc c'est une urgence d'exploration et ensuite de traitement. Il en est de même pour le nerf facial, c'est une urgence maxillofaciale qui relève de spécialistes.

Les lésions aussi du canal parotidien et les voies lacrymales. Donc en cas de difficulté et que la non disponibilité de spécialistes, il faut protéger les plaies et attendre les avis avant de les fermer. Et là on voit un exemple de grandes plaies complexes, donc frontaux temporo-jugales avec perte de substance, du sourcil, de la région latéro-faciale, mais aussi une plaie de transfection du globe et qui touche le globe oculaire.

Et là c'est une plaie complexe et urgence ophtalmologique et maxillofaciale qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire pour permettre d'assurer la fonction, la morphologie et la latence complète et globale de prise en charge. Toujours dans les particularités des formes complexes qui relèvent de médecins spécialistes et de prises en charge spécialisées, les dermabrasions imposent un brossage de la peau pour prévenir les tatouages. Et bien souvent elles sont laissées sans traitement et elles relèvent donc d'une prise en charge spécialisée.

Les syndromes de pare-brise qui se manifestent par des plaies multiples, le cas de ce patient, donc avec des fractures faciales multiples, mais aussi un délabrement facial par pare-brise, et donc qui relève d'une réparation complexe ostéocutanée comme on voit sur le résultat post-opératoire. Les pertes de substance vont nécessiter de les protéger et de les réparer secondairement, donc pareil qui nécessite une prise en charge spécialisée. Les traumatismes balistiques relèvent de prises en charge multidisciplinaires.

D'abord la réanimation pour assurer le volet vital de ces traumatismes, le maintien des espaces par le chirurgien et un bon bilan lésionnel initial. Parce que bien souvent les temps de réparation se font en plusieurs fois et ce bilan lésionnel va dicter le reste de la conduite pratique. Et enfin les morsures faciales comme un dernier informe complexe de plaies faciales.

J'ai laissé cette diapo toute seule parce que c'est la seule urgence infectieuse de nos plaies faciales. Elle impose de décontaminer donc la plaie sur le plan infectieux parce que ces morsures qui relèvent soit de morsure animale ou humaine sont très sceptiques donc lavage abondant des antibiotiques du sérum antitétanique et du vaccin antitétanique. Elle impose de parer les tissus dévitalisés et qui sont contaminés et de soigner.

Les soins comportent deux volets soit des soins avant la sixième heure ou bien des soins après la sixième heure. Au niveau de la face nous pouvons réparer avant la sixième heure où la plaie est encore sur le plan sceptique et capable de cicatriser après réparation. Et bien sûr pour d'autres régions du corps elles sont proscrites ces réparations.

Après la sixième heure la face s'aligne exactement comme les autres régions de la face et impose la cicatrisation dirigée et de pérenniser les espaces dans l'attente du nettoyage de la

plaie pour établir par la suite peut-être une réparation secondaire et enfin la déclaration obligatoire. Ces morsures sont essentielles à connaître par le médecin généraliste et par le médecin spécialiste et nous estimons que ces urgences infectieuses doivent être prises en charge correctement depuis les premières heures parce que si on peut réparer ces morsures cela évite les séquelles esthétiques, morphologiques et fonctionnelles conséquentes de ces plaies. En conclusion les plaies faciales représentent l'urgence la plus fréquente en chirurgie maxillofaciale et dans notre contexte elles sont très fréquentes et nous estimons que nos médecins généralistes doivent être capables d'assurer le volet de la plaie simple et de gérer la plaie complexe.

Ces plaies complexes ou simples qui sont en apparence banales et qui peuvent être graves soit par des lésions associées sous-jacentes ou bien des lésions associées dans le cadre d'un polytraumatisé. Des plaies complexes par leur complexité anatomique lésionnelle mais également par leurs séquelles handicapantes. Une plaie mal prise en charge même si elle est simple peut laisser des séquelles morphologiques et esthétiques handicapantes sur le plan professionnel, handicapantes sur le plan social et handicapantes sur le plan psychologique.

Le seul traitement c'est la conduite stéréotypée par un examen clinique précis à l'admission du patient, par une exploration soigneuse, par une réparation minutieuse et par une prévention réelle des accidents de la voie publique et des agressions qui sont les pourvoyeurs de ces plaies de la face.